CLASE ESPECIAL

URGENCIAS QUIRÚRGICAS: XABCDE

DR. ALBERTO PERDOMO

LA "X": HEMORRAGIA EXANGUINANTE

- Se antepone al ABCDE tradicional: control inmediato de hemorragias masivas en extremidades (amputaciones traumáticas) con compresión directa, empaquetamiento hemostático o torniquete, ANTES de cualquier maniobra en vía aérea.

GOLDEN HOUR Y TRIAGE PREHOSPITALARIO

- La primera hora tras el trauma concentra la mayor mortalidad evitable; traslado rápido al centro de trauma de nivel adecuado según la gravedad de las lesiones.

VÍA AÉREA CON CONTROL CERVICAL (A)

- Contraindicada la maniobra frente-mentón en trauma; se exige tracción mandibular (jaw-thrust).
- Obstrucción completa: 5 golpes interescapulares + 5 compresiones abdominales (Heimlich); en embarazadas/obesos, compresiones torácicas.
- Anafilaxia: adrenalina IM en vasto lateral, 0.3-0.5mg (1:1,000).

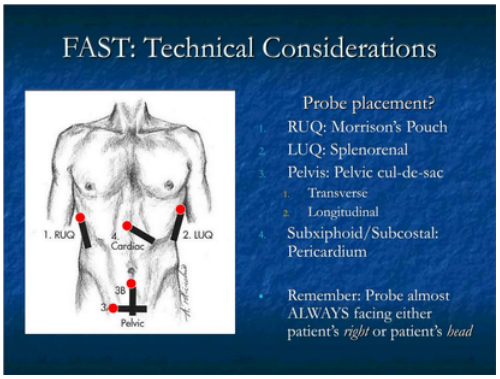
ACCESO VASCULAR DE EMERGENCIA

- Vía intraósea (tibial o húmero proximal) cuando el acceso periférico falla en 2 intentos o 90 segundos; permite infundir cualquier fármaco o fluido de reanimación.



RESPIRACIÓN Y CIRCULACIÓN (B/C)

- Neumotórax a tensión: disnea, hipotensión, ingurgitación yugular, timpanismo; descompresión con aguja (5º espacio intercostal línea medioaxilar) + toracostomía.
- Estabilización pélvica: empaquetamiento circunferencial centrado en trocánteres mayores ante fractura en "libro abierto".
- Taponamiento cardíaco: tríada de Beck (hipotensión, ingurgitación yugular, ruidos velados); confirmación con eFAST, toracotomía o pericardiocentesis.



EVALUACIÓN SECUNDARIA (AMPLIA)

- Una vez estabilizado el ABCDE: historia AMPLIA (Alergias, Medicamentos, Patologías previas, Libaciones/última comida, Ambiente del evento) y examen físico de cabeza a pies.

DISCAPACIDAD Y EXPOSICIÓN (D/E)

- Anisocoria: signo indirecto de hipertensión endocraneana o herniación uncal.
- Glucometría capilar inmediata en toda alteración del estado mental (descartar hipoglucemia).
- Exposición: desnudamiento completo, recalentamiento con fluidos tibios e iluminación radiante.

REEVALUACIÓN CONTINUA

- El ABCDE no es lineal: cualquier deterioro obliga a reiniciar la secuencia desde A; la reevaluación frecuente es lo que detecta lesiones ocultas.

CLASE ESPECIAL

URGENCIAS QUIRÚRGICAS: XABCDE

DR. ALBERTO PERDOMO

EVALUACIÓN DEL HABLA

- Responder con fluidez confirma la permeabilidad; estridor, disfonía o secreciones sugieren obstrucción inminente.

CAÍDA DE LA LENGUA

- En el paciente inconsciente, la caída posterior de la base de la lengua es la causa primaria de obstrucción de la vía aérea superior.

DISPOSITIVOS BÁSICOS

- Cánula orofaríngea (Guedel) sin reflejo nauseoso; cánula nasofaríngea en semiconscientes.

CUERPO EXTRAÑO EN LACTANTES

- 5 palmadas en la espalda y 5 compresiones torácicas sobre el esternón; si pierde la conciencia, iniciar RCP.

SOPORTE VENTILATORIO

- Mascarilla de no reinhalación con reservorio al 100% (10–15 L/min); bolsa-válvula-mascarilla si hay hipoventilación.

SITIOS DE DESCOMPRESIÓN CON AGUJA

- Catéter 14G en el 5.º EIC línea medioaxilar o 2.º EIC línea medioclavicular; luego tubo pleural a sello de agua.

HEMOTÓRAX

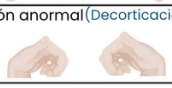
- Evacuación rápida con tubo torácico de grueso calibre (28–32 Fr).

EVALUACIÓN PERFUSORIA

- Pulsos, frecuencia cardíaca, llenado capilar (>2 s es patológico) y presión arterial.

ESCALA DE GLASGOW

- Respuesta ocular 1–4, verbal 1–5 y motora 1–6.

	OCULAR (4)	VERBAL (5)	MOTORA (6)
	Cuatro 		
No Valorable	No Valorable	No Valorable	No Valorable
1	Sin respuesta	Sin respuesta	Sin respuesta
2	A la presión	Sonidos (2)	Extensión (Descerebración) 
3	Al sonido	Palabras	Flexión anormal (Decorticación) 
4	Espontánea (Obedece órdenes)	Confusa	Flexión normal (Retirada al dolor)
5	-	Orientada (Obedece órdenes)	Localiza dolor
6	-	-	(Obedece órdenes)

Si es No Valorable no se suma al puntaje total, solo se reporta como NV

CASO CLÍNICO: PRESENTACIÓN

- Varón de 22 años llevado en taxi por herida de arma blanca en hemitórax izquierdo: disnea grave, PA 60/40, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados.

CASO CLÍNICO: A Y B

- A: vía aérea permeable (frases entrecortadas).
- B: murmullo vesicular claro y simétrico bilateral: excluye el neumotórax a tensión pese a la disnea y la ingurgitación yugular.

CASO CLÍNICO: C

- Ingurgitación yugular + hipotensión profunda + ruidos cardíacos velados = tríada de Beck: taponamiento cardíaco traumático.

CASO CLÍNICO: CONDUCTA

- Confirmar el hemopericardio con la ventana pericárdica del eFAST y llevar a quirófano para toracotomía o ventana pericárdica; pericardiocentesis guiada si la cirugía se demora.